

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Da Saúde (arts. 196 a 200 da CF/1988)

A disciplina constitucional da área de Saúde está compreendida **nos artigos 196 a 200**. Estabelece a CF que a saúde **é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e o acesso universal e igualitário a ações e serviços para sua promoção, recuperação e proteção**.

Histórico

Antes de tudo, vamos dar uma olhada nas raízes do nosso sistema de saúde:

(i) Início do Século XX: inicia-se uma campanha sanitarista, com a fundação, em 1900, do **Instituto Soroterápico Nacional - Fiocruz**;

(ii) Em 1904, institui-se a vacinação obrigatória contra a Varíola, motivada, em grande parte, pela chamada "**Revolta da Vacina**", movimento popular ocorrido no Rio de Janeiro;

(iii) Em 1920, cria-se o **Departamento Nacional de Saúde Pública**, quando são estabelecidas as bases para a criação de um Sistema Nacional de Saúde, caracterizado pela concentração e verticalização das ações no governo central;

(iv) Em 1937 é criado o **Ministério da Educação e Saúde**, além dos primeiros institutos de aposentadorias e pensões (IAPs); por volta de 1945, havia apenas 2 milhões de pessoas vinculadas a institutos de previdência, que custeavam parte das despesas médicas de seus associados. Em meados dos anos 1960 esse número saltou para mais de 8 milhões de segurados, fora dependentes.

(v) Em 1953 é criado o **Ministério da Saúde**;

(vi) Em 1960, após forte pressão de sindicatos o Governo sancionou a **Lei Orgânica da Previdência Social**, que igualou o valor a ser pago pelos trabalhadores e pelos empregadores e o Governo Federal, em percentual de 8%.

(vii) Em 1963, durante a III Conferência Nacional de Saúde, estabelecem-se as primeiras diretrizes para a **municipalização das ações de saúde**;

(viii) O período do regime de exceção, a partir de 1964, é marcado por características singulares:

a) predomínio financeiro das instituições previdenciárias;

b) Unificação dos IAPs no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS);

c) Privatização dos serviços médicos, em 1978 (INAMPS);

d) Predomínio da medicina curativa, hospitalo-cêntrica.

ix) Em 1986, a **VIII Conferência Nacional de Saúde** foi fundamental na propagação do movimento de reforma sanitária, e serviu de base para os debates sobre saúde na assembleia nacional constituinte, implantação do **Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS)**, por meio de convênio entre o INAMPS e os governos estaduais, bem como o estabelecimento das diretrizes para a Seção "**Da Saúde**", da **CF/1988, em seus artigos 196 a 200**;

x) Em 1990, já na vigência da nova Constituição, o Decreto 99.060/90 incorpora o INAMPS ao Ministério da Saúde, e o instituto vem a ser extinto em 1993; no mesmo ano, é publicada a Lei 8.080/90, a Lei Orgânica da Saúde, instituindo as diretrizes do atual **Sistema Único de Saúde (SUS)**. A Constituição Federal de 1988 é considerada uma ruptura com o princípio da meritocracia, ao incorporar a saúde à ideia de cidadania. Isso na teoria, pois na prática, a universalização dos serviços de saúde, sem as correspondentes fontes de financiamento total, a par dos desvios de recursos e contingenciamentos orçamentários, tem se mostrado inviável.

Mesmo com a instituição da antiga CPMF (contribuição provisória sobre movimentação financeira), apenas 55% dos recursos dessa contribuição eram efetivamente direcionados aos serviços de saúde, além da "substituição" orçamentária dos recursos do orçamento geral pelos da Contribuição, e não a união desses recursos.

Disciplina Constitucional das ações e políticas de Saúde e do Sistema Único de Saúde

Estabelece o **artigo 196** da Constituição que a saúde é **direito de todos e dever do Estado**, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Já o **artigo 197** estipula que **são de relevância pública as ações e serviços de saúde**, cabendo ao Poder Público dispor, **nos termos da lei**, sobre sua **regulamentação, fiscalização e controle**, devendo sua **execução** ser feita **diretamente ou através de terceiros** e, também, por **pessoa física ou jurídica de direito privado**. Perceba que é somente a **execução** que pode ser delegada a terceiros, como serviço público social não exclusivo.

A **regulamentação, a fiscalização e o controle** permanecem sob **titularidade e execução do Poder Público**.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

O SUS é integrado por uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, e constitui o meio pelo qual o Poder Público executa as ações e programas de saúde, sendo organizado de acordo com as seguintes **diretrizes** (art. 198, CF):

- a) **Descentralização**, com direção única em cada esfera de governo;
- b) **Atendimento integral**, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
- c) **participação** da comunidade.

O sistema único de saúde (SUS) é financiado com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos estados, do DF e dos municípios, além de outras fontes (art. 198, § 1º).

A CF determina que essas entidades apliquem, anualmente, em ações e serviços de saúde, recursos do produto de suas arrecadações tributárias e de transferências **em percentagens e critérios estabelecidos pela própria Constituição e não mais, no caso da União, em lei complementar** nos termos da nova redação dada pela **Emenda Constitucional 86/2015** aos §§ 2º e 3º do art. 198:

Art. 198.....

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. **(Parágrafo único renumerado para § 1º pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)**
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art6)

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: **(Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)**
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art6)

~~I - no caso da União, na forma definida nos termos da lei complementar prevista no § 3º; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)~~
~~**(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art6)**~~

I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze por cento); **(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)**
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc86.htm#art1)

~~II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)~~
~~**(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art6)**~~

II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 155 e 156-A e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, I, "a", e II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; **(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)**

~~III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)~~
~~**(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art6)**~~

III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 156 e 156-A e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, I, "b", e § 3º. **(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)**

§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, estabelecerá: **(Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)**
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art6)

~~I - os percentuais de que trata o § 2º; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)~~
~~**(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art6)**~~

I - os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2º; **(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)**
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc86.htm#art1)

II - os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais; **(Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)**
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art6)

III - as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal; **(Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)** (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art6)

IV - Revogado

A **Lei Orgânica da Saúde** (Lei 8.080/1990) estabelece ainda os seguintes **princípios**, para o desenvolvimento das ações de saúde, públicas ou contratadas e conveniadas que integram o sistema único de saúde:

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;

II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;

IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;

V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;

VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário;

VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;

VIII - participação da comunidade;

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;

X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico;

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;

XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

Sob o argumento de assegurar maior eficiência na saúde pública e no combate às endemias, o texto constitucional passou a dispor ainda que os gestores locais do SUS podem **admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias** (p. ex., dengue, gripe suína, ebola 🤒), por meio de **processo seletivo público (não é concurso público)**, de acordo com a natureza e complexidade das funções, o que deve ser disciplinado em lei federal, que tratará também do regime jurídico e da remuneração dos agentes. A Lei que trata do assunto é a **11.350/2006**.

É, sem dúvida, mais uma exceção ao princípio do concurso público, já que a seleção não se dará necessariamente pelo processo seletivo do art. 37, II.

Nos termos do **art. 199**, a assistência à saúde é **livre à iniciativa privada** e as instituições poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, de acordo com as diretrizes do SUS, com prioridade para as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos.

O **§ 1º a 3º do art. 199** prevê a celebração de contrato (de direito público) ou convênio com entidades privadas, que atuem complementarmente no sistema único de saúde. Esses contratos têm sido cada vez mais comuns, e seu controle é predominantemente **finalístico e de resultados**, uma vez que não há previsão legal expressa para que as

entidades privadas sujeitem-se às normas de direito público (licitações, contratação de pessoal e outras), não obstante possa e deva ocorrer o controle financeiro e orçamentário dos recursos repassados.

*Art. 199, § 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante **contrato de direito público ou convênio**, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.*

*§ 2º - É vedada a destinação de recursos públicos para **auxílios ou subvenções** às instituições privadas com fins lucrativos.*

§ 3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

§ 4º - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.

Esse contrato, entretanto, não se confunde com o **contrato de gestão** firmado entre entidades públicas, nos termos do § 8º do art. 37 da CF:

Art. 37 - § 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:

I - o prazo de duração do contrato;

II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes;

III - a remuneração do pessoal.

Segundo o **art. 200** ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei (com a inclusão da **Inovação**, no inciso V, introduzida pela **Emenda Constitucional 85/2015**):

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;

V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico;

*V - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a **inovação**; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc85.htm#art1).*

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

Importante: O Supremo Tribunal Federal tem confirmado decisões judiciais que determinaram ao Sistema Único de Saúde (SUS) o fornecimento de remédios de alto custo ou tratamentos não oferecidos pelo sistema a pacientes de doenças graves que recorreram à Justiça. Com esse resultado, essas pessoas ganharam o direito de receber os medicamentos ou tratamentos pedidos pela via judicial, sem que haja discriminação quanto à situação de vulnerabilidade financeira do necessitado.

Não obstante, o STF tem alertado para que cada caso seja avaliado sob o critério da necessidade, no sentido de não gerar grave lesão à ordem administrativa e comprometimento do SUS. Essa necessidade relaciona-se, por exemplo, a tratamentos puramente experimentais daqueles já reconhecidos, mas não testados pelo sistema de saúde brasileiro. No caso daqueles, o Estado não poderia, em princípio, ser condenado a fornecê-los. (**dentre outros, Suspensões de Tutela (STA) 175, 211 e 278; Suspensões de Segurança 3724, 2944, 2361, 3345 e 3355; Suspensão de Liminar (SL) 4**).

Ao confirmar o direito subjetivo público a políticas públicas que promovam, protejam e recuperem a saúde, o STF assentou que "não obstante, esse direito subjetivo público é assegurado mediante políticas sociais e econômicas, ou seja, **não há um direito absoluto a todo e qualquer procedimento necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde**, independentemente da existência de uma política pública que o concretize. Há um direito público subjetivo a políticas públicas que promovam, protejam e recuperem a saúde" (**STA 198, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. em 22/12/2008**).

De outra borda, o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar **ação civil pública** objetivando o fornecimento de remédio pelo Estado (**CF, art. 129, II e STF, RE 407902/RS, rel. Min. Marco Aurélio, 26.5.2009**).



Já caiu em prova!

Conforme Tese de Repercussão Geral firmada pelo Supremo, o ressarcimento de serviços de saúde prestados por entidades hospitalares privadas em favor de paciente do Sistema Único de Saúde em cumprimento de determinação judicial, **deve utilizar os mesmos critérios adotados para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde**. Segundo o Supremo, o ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração

de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). Para conciliar essa antinomia, o STF considerou razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde:

"Ementa: Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. (...) 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde". (RE 666.094 - Repercussão Geral – Mérito (Tema 1033) relator Min. Roberto Barroso, julgamento em 30/9/2021)



Jurisprudência

O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais, e, como regra geral, a ausência de registro na ANVISA impede o fornecimento de medicamento por decisão judicial. É excepcionalmente possível a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário em caso de mora irrazoável da ANVISA na análise do pedido de registro, desde que exista pedido de registro do medicamento no Brasil, registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior e inexistência de substituto terapêutico no Brasil.

Como regra geral, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por decisão judicial. O registro na Anvisa constitui proteção à saúde pública, atestando a eficácia, segurança e qualidade dos fármacos comercializados no país, além de garantir o devido controle de preços. 4. Provimento parcial do recurso extraordinário, apenas para a afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União”. (RE 657.718, rel. p/ o ac. min. Roberto Barroso, j. 22/5/2019, P, DJE de 9-11-2020, Tema 500)

É **constitucional** ato normativo que, no âmbito do Sistema Único de Saúde, veda a internação em acomodações superiores e o atendimento diferenciado por médico do próprio Sistema Único de Saúde, mediante o pagamento da diferença dos valores correspondentes:

O procedimento da “diferença de classes”, tal qual o atendimento médico diferenciado, quando praticados no âmbito da rede pública, não apenas subverte a lógica que rege o sistema de seguridade social brasileiro, como também afronta o acesso equânime e universal às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde, violando, ainda, os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Inteligência dos arts. 1º, inciso III; 5º, inciso I; e 196 da Constituição Federal. 3. Não fere o direito à saúde, tampouco a autonomia profissional do médico, o normativo que veda, no âmbito do SUS, a assistência diferenciada mediante pagamento ou que impõe a necessidade de triagem dos pacientes em postos de saúde previamente à internação. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 581.488, relator Min. Dias Toffoli, julgamento 3/12/2015)

O próprio Supremo e o STJ têm reconhecido o direito público subjetivo a determinados direitos sociais fundamentais, como saúde e educação:

"não obstante, esse direito subjetivo público é assegurado mediante políticas sociais e econômicas, ou seja, não há um direito absoluto a todo e qualquer procedimento necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente da existência de uma política pública que o concretize. Há um direito público subjetivo a políticas públicas que promovam, protejam e recuperem a saúde" (STF, STA 198, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. em 22/12/2008).

Além disso, Estado e União podem figurar conjuntamente no polo passivo da demanda, em função da responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao dever de prestar tratamento de saúde adequado a quem o necessite:

"Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O **polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente**. Destaco, inicialmente, que a discussão posta nos autos **não se confunde** com aquela travada no RE 566.471-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, em que se debate o dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave **que não possui condições financeiras para comprá-lo** (RE 855.178 RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5/3/2015, Plenário,Tema 793)".

"A União, Estados-Membros e Municípios têm legitimidade passiva e responsabilidade solidária nas causas que versam sobre fornecimento de medicamentos. 2. A prescrição do tratamento deverá ser feita, preferencialmente, por médicos credenciados ao SUS, além da respectiva realização de perícia médico-judicial, se for o caso, bem como demonstração da parte autora, quanto à impossibilidade de arcar com a aquisição dos medicamentos, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.)". (STJ, AREsp 605.392 PR 2014/0285112-0, relator Min. Herman Benjamin, julg. em 3/11/2014)



Veja como foi cobrado!

(CESPE/JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO/TRF 5ª REGIÃO/2011) Em razão da essencialidade do direito à saúde, o Estado não pode afastar-se do mandato, juridicamente vinculante, que lhe foi outorgado pela CF, embora as opções do poder público, tratando-se de proteção à saúde, possam ser exercidas com apoio em juízo de conveniência ou de oportunidade, razão pela qual é indevida a intromissão do Poder Judiciário quando atue positivamente para garantir direito dessa natureza.

Essa afirmação vai contra a tendência atual de judicialização das políticas públicas na qual o Estado-Juiz interfere excepcionalmente quando houver necessidade de garantir o exercício de um direito fundamental social como é o da saúde.

Segundo o STF, não pode o Executivo invocar a questão da reserva do financeiramente possível sempre que a invocação dessa cláusula puder comprometer o núcleo básico que qualifica o mínimo existencial. Nesse caso, caracteriza-se o desrespeito à Constituição pela inércia estatal.

Normalmente, tais intervenções fazem-se no caso concreto, como na realização de uma cirurgia, de um exame ou na aquisição de um medicamento indisponível na rede pública.

Gabarito: **ERRADO**.

(ESAF/AUDITOR FISCAL DO TRABALHO/MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/2010) A saúde integra o tópico da Constituição Federal que trata da Ordem Social. A saúde é um direito de todos e dever do Estado. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único. Sobre a saúde, é correto afirmar que

a) lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, vedada a previsão de piso salarial nacional.

b) o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias são previstos na Constituição. Tais regimes e regulamentações são suficientes para garantir as prerrogativas das duas classes, por tratar-se de um comando normativo constitucional auto aplicável.

c) lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.

d) lei complementar disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, vedada a previsão de piso salarial nacional.

e) os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias sem processo seletivo público, nas condições previstas na Constituição Federal, avaliando-se as circunstâncias, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

A letra “a” está **incorreta** pois o § 8º do art. 198, com a redação dada pela EC 63/2010, estabelece que federal disporá sobre o regime jurídico, o **piso salarial profissional nacional**, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.

A letra “b” está **errada** com base na letra “a” pois a mesma lei ordinária irá dispor sobre o regime jurídico e regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e de combate às endemias (art. 198, § 8º).

A letra “c” está **correta** e reproduz o comando constitucional citado acima.

A letra “d” está **errada** pois a lei será **ordinária**, e incluirá previsão de **piso salarial** profissional nacional.

A letra “e” está **errada** pois Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias **por meio de processo seletivo público**, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. Perceba que não é mediante concurso público de provas ou provas e títulos, mas processo seletivo público, o que configura exceção ao princípio do concurso público para adentrar no serviço público.

Gabarito: **Item C.**

Resumo



Fundamentos Constitucionais

- Art. 196: Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida por políticas sociais e econômicas, com acesso universal e igualitário.
- Art. 197: Ações e serviços de saúde são de relevância pública, com regulamentação, fiscalização e controle pelo Poder Público; a execução pode ser feita por terceiros.
- Art. 198: Diretrizes do SUS:
 - Descentralização com direção única;
 - Atendimento integral, com foco na prevenção;
 - Participação da comunidade.

- Financiamento do SUS: Recursos da seguridade social, arrecadações tributárias e transferências. Percentuais mínimos definidos na CF após a EC 86/2015 e EC 132/2023.



Histórico do Sistema de Saúde no Brasil

- 1900-1960: Criação da Fiocruz, vacinação obrigatória (1904), criação do Ministério da Saúde (1953).
- 1960-1980: Lei Orgânica da Previdência (1960), criação do INPS, privatização crescente dos serviços (INAMPS).
- 1986: VIII Conferência Nacional de Saúde e movimento da reforma sanitária.
- 1988: Constituição inclui a saúde como direito de cidadania e propõe o SUS.
- 1990: Lei 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde); extinção do INAMPS.



Princípios do SUS (Lei 8.080/1990)

- Universalidade, integralidade e equidade.
- Autonomia e direito à informação.
- Descentralização, regionalização e hierarquização.
- Participação da comunidade.
- Integração com meio ambiente e saneamento.
- Capacidade de resolução e racionalização de meios.



Agentes Comunitários e Combate às Endemias

- Admitidos por **processo seletivo público**, conforme Lei 11.350/2006.
- Exceção ao concurso público (CF, art. 37, II).



Participação da Iniciativa Privada (Art. 199 CF)

- Permitida de forma complementar, mediante contrato ou convênio com prioridade para entidades filantrópicas e sem fins lucrativos.
- Vedado repasse de recursos a instituições com fins lucrativos e a participação de capital estrangeiro, salvo lei específica.
- Diferença de classes no SUS é inconstitucional (RE 581.488/2015).



Competências do SUS (Art. 200 CF)

- Controle e produção de insumos.
- Vigilância sanitária e epidemiológica.
- Formação de profissionais.
- Saneamento, meio ambiente e saúde do trabalhador.
- Fiscalização de alimentos, substâncias e inovação tecnológica (EC 85/2015).



Jurisprudência e Responsabilidade Estatal

- **STF reconhece o direito à saúde como direito subjetivo público**, condicionado à existência de políticas públicas.
- **Fornecimento judicial de medicamentos:**
 - Permitido para remédios de alto custo.
 - Não obrigatório para medicamentos experimentais ou sem registro na ANVISA, salvo em casos excepcionais (RE 657.718/2020).
- **Responsabilidade solidária** dos entes federativos (União, Estados, Municípios) no dever de fornecer tratamento (RE 855.178/2015).
- **Ministério Público** pode propor ação civil pública para garantir medicamentos (RE 407.902/RS).

💰 **Ressarcimento de Entidades Privadas (RE 666.094/2021 - Tema 1033)**

- O reembolso deve seguir os **valores da Tabela do SUS**.
 - Cobrança de valor de mercado é inconstitucional por violar a livre iniciativa e a propriedade privada.
-

Texto: Professor(a) Jean Claude O'Donnell Braz Pereira

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
